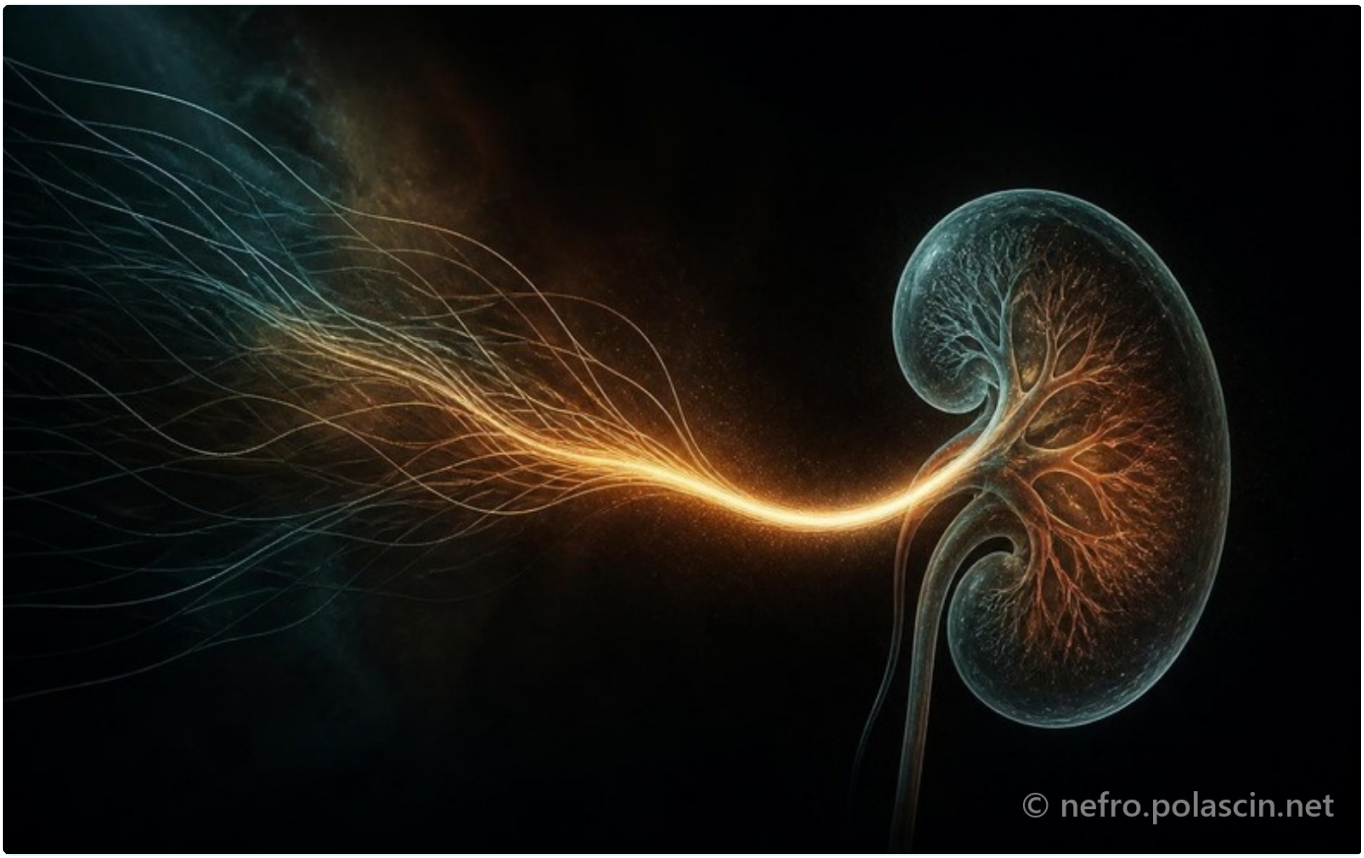
Znižovanie krvného tlaku u pacientov s chronickou chorobou obličiek: metaanalýza

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 08.05.2026



Ilustračná scéna. To, čo jednotlivé štúdie iba naznačujú, spojená analýza ukáže zreteľne.

V apríli 2026 časopis *The Lancet* publikoval individuálnu metaanalýzu dát (individual-participant data meta-analysis), ktorá skúmala, či znižovanie krvného tlaku prináša rovnaký kardiovaskulárny prínos pacientom s chronickou chorobou obličiek (CKD) aj pacientom bez CKD. Ide o doteraz najrozsiahlejšiu analýzu tohto typu.

Dizajn a populácia

Vedci z Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration analyzovali údaje zo 46 randomizovaných štúdií zahŕňajúcich **285 124 účastníkov**. Z nich malo 20,7 % CKD a 30,2 % diabetes 2. typu. Medián sledovania bol 4,4 roka. Primárnym sledovaným ukazovateľom boli závažné kardiovaskulárne príhody (fatálna alebo nefatálna cievna mozgová príhoda, ischemická choroba srdca, hospitalizácia alebo úmrtie pre srdcové zlyhanie).

Hlavné výsledky

Konzistentný prínos naprieč štádiami CKD – Každé zníženie systolického tlaku o 5 mm Hg bolo spojené s približne 9 – 10 % relatívnym znížením rizika závažných kardiovaskulárnych príhod. Tento efekt bol prakticky rovnaký u pacientov s CKD (HR 0,91; 95 % CI 0,87 – 0,94) aj bez CKD (HR 0,90; 95 % CI 0,88 – 0,93). Nezistila sa heterogenita účinku naprieč štádiami CKD vrátane štádií 4 – 5 ani podľa prítomnosti proteinúrie.

Efekt aj pri nízkom východiskovom tlaku – Prínos pretrvával aj u pacientov s východiskovým tlakom pod 120/70 mm Hg, čo naznačuje, že neexistuje jasný „prah“, pod ktorým by liečba strácala zmysel.

Triedy liekov – Sieťová metaanalýza ukázala, že hlavné triedy antihypertenzív (ACE inhibítory, blokátory receptorov angiotenzínu, blokátory kalciových kanálov, diuretiká, betablokátory) mali podobný relatívny účinok voči placebu. Prínos teda nie je viazaný na konkrétnu triedu, ale na samotné zníženie tlaku.

Výnimka – pacienti s CKD a diabetom – V rámci podskupiny CKD bol účinok liečby významne slabší u pacientov s diabetom (HR 0,96; 95 % CI 0,90 – 1,02) oproti pacientom s CKD bez diabetu (HR 0,88; 95 % CI 0,84

– 0,93). Interakcia bola štatisticky významná (p = 0,044). Tento signál vyžaduje ďalšie overenie.

Čo to znamená v praxi?

Zistenia podporujú **univerzálne znižovanie kardiovaskulárneho rizika** pomocou antihypertenzívnej liečby u pacientov s CKD – bez ohľadu na štádium ochorenia, východiskový tlak alebo triedu lieku. Výnimku môžu tvoriť pacienti s kombináciou CKD a diabetu, kde je prínos menej výrazný a rozhodovanie by malo byť individuálne.

Autori zdôrazňujú, že liečba by sa nemala odkladať ani u pacientov s pokročilým CKD (štádium 4 – 5), ktorí sú často z kardiovaskulárnych štúdií vylučovaní.

Zdroj: ReachMD / The Lancet, publikované v apríli 2026

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=znizovanie-krvneho-tlaku-u-pacientov-s-ckd-metaanalaza · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.